

 	Hôpital Bicêtre	Procédure Réf : smq-reference Version : 1 Date d'application : smq-dateapplication Date de fin de validité : smq-limval Page 1 sur 5
	Hôpital Bicêtre PROTOCOLE : MISE EN POSTURE DÉCUBITUS LATÉRALE	

	NOM, FONCTION	DATE
RÉDACTION	Bouix jean	12/02/26
VALIDATION		Date de validation
APPROBATION	smq-approbateurs	Date d'approbation

Groupe de travail : Installation en posture chirurgicale au bloc opératoire pluridisciplinaire dans le cadre des actes relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat

Principales modifications par rapport à la version précédente : smq-objet-modif

1. OBJET

Réalisation de l'installation définitive du patient en décubitus latéral droit par l'infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat (IBODE) de l'hôpital Bicêtre dans le cadre de sa compétence exclusive et en vue de l'intervention chirurgicale : surrenalectomie laparoscopique gauche ou droite avec assistance robotique.

La surrenalectomie est la technique de référence pour la prise en charge des tumeurs surrenaliennes. L'approche mini-invasive, optimisée par l'assistance robotique, s'impose aujourd'hui comme une modalité incontournable, permettant une dissection précise, une réduction de la morbidité et une récupération post-opératoire améliorée.

2. DOMAINE D'APPLICATION

L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire est seule habilitée à accomplir les actes ou activités, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par les chirurgiens du bloc opératoire, sous réserve qu'un chirurgien puisse intervenir à tout moment : l'installation en posture chirurgicale au bloc opératoire pluridisciplinaire en dehors de la présence du chirurgien.

Cette procédure s'adresse aux Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d'Etat ayant validé la formation de 49 heures aux actes relevant de la compétence exclusive. Elle sera mise en œuvre au bloc opératoire et concernera l'ensemble des spécialités de chirurgie réalisées à l'hôpital Bicêtre pour le secteur de chirurgie viscérale et digestive.

Les Infirmiers en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peuvent participer en présence d'une IBODE à la réalisation et à la validation de l'installation en posture chirurgicale.

3. RESPONSABILITÉS/ PERSONNES CONCERNÉES

IBODE, IDE, étudiant IBODE, chirurgiens, internes en chirurgie, externe, MAR, IADE, aide-soignant, agent hospitalier.

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

CF DOCUMENT JOINT

5. INDICATION ET BUT

Installation provisoire en décubitus dorsal :

Le décubitus dorsal est une position standard de référence permettant de réaliser l'anesthésie. Elle est toujours la même mais peut être modulée selon le type d'anesthésie (ex : anesthésie locorégionale). Le patient est, la majeure partie du temps, en décubitus dorsal strict (la tête, le tronc et les jambes dans l'axe du corps) : - La tête repose sur un rond de tête en polymère viscoélastique pour le confort du patient,

- Les bras sont installés en abduction inférieure à 90° sur des appui-bras de chaque côté,
- Le patient est sangle pour éviter les chutes au moment de l'induction,
- On propose au patient une couverture chauffante, afin d'éviter le risque d'hypothermie.

L'installation provisoire en décubitus dorsal permet d'assurer la sécurité, le confort et la pudeur du patient et de pouvoir « technique » le patient (intubation, dispositifs de surveillance, perfusion).

6. INSTALLATION

7.

Installation définitive en décubitus dorsal avec les deux bras le long du corps

L'installation définitive en décubitus dorsal avec les deux bras le long du corps facilite l'abord chirurgical en chirurgie viscérale, car cela améliore l'exposition du site opératoire.

6.1 Matériel

- Une table d'opération standard,
- Un gel viscoélastique couvrant l'ensemble de la surface de la table,
- Un rond de tête en gel viscoélastique standard, et un second épais et fendu,
- Un appui-bras mobilisable pour le bras droit, à droite,
- Un appui de type GOEPEL pour le bras gauche surélevé, à droite,
- Une sangle de maintien,
- Billot sous-thoracique/sous-scapulaire en gélose,
- Un billot sous lombaire en gélose,
- Un appui sacré et un appui dorsal,
- Deux talonnettes en gel viscoélastique,
- Une gélose entre les membres inférieurs,
- Bas de contention si nécessaire,
- Couverture chauffante trouée en son centre,
- Un rouleau d'Elastoplast®

6.2 L'installation

Impression pour information. Seule la version électronique fait foi.

6.2.1 Installation provisoire en décubitus dorsal strict

- La tête dans l'axe du corps sur un rond de tête viscoélastique,
- Les bras sur appui-bras en abduction inférieure à 90°, les mains en supination,
- Le thorax, bassin et jambes sont dans le même alignement,
- Le patient est d'emblée positionné à la bonne position sur la table d'opération, la cassure de la table est sous les lombes.
- Vérification du positionnement du patient par rapport au billot électrique de la table
- Il existe naturellement une flexion et abduction à 30° de la hanche, en légère rotation externe,
- Il existe naturellement une flexion plantaire de 10° de la cheville,
- Une couverture chauffante trouée au centre est placée sur le patient, dégageant la zone à opérer
- Une sangle de maintien est positionnée au niveau du muscle droit antérieur du patient.
- On peut placer sous les genoux du patient un billot afin de soulager le dos et d'améliorer la circulation veineuse des membres inférieurs, et des talonnettes en gel viscoélastique sous les talons du patient.

6.2.2 Installation définitive en décubitus latéral droit

Le patient repose sur le côté opposé au côté opéré au bord de la table,

La tête est légèrement surélevée grâce à un rond de tête épais en gel viscoélastique fendu afin d'aligner le rachis cervical et dorsal.

- Le bras inférieur droit est positionné en antépulsion < à 90° sur un appui-bras standard, la main est en supination, l'épaule doit être dégagée vers l'avant-bras grâce à un billot axillaire adapté à la morphologie du patient et positionné sous la pointe de l'omoplate ; maintenu par une sangle. On peut positionner un billot sous-scapulaire afin de dégager l'épaule et favoriser la respiration.
- Le bras supérieur gauche est positionné en antépulsion, fléchi à 90° sur un appui type Goepel surélevé avec une gélose sous le coude. L'absence de contrainte (hyper extension, compression) sur le plexus brachial est vérifiée.
- La table d'opération est « cassée » au niveau du rein droit, afin d'ouvrir l'espace rétro péritonéal opposé (gauche).
- Si besoin, un billot supplémentaire peut être rajouté au niveau de l'espace lombaire droit.
- Une bande Elastoplast® est positionnée au niveau du torse pour maintenir le patient plaqué contre l'appui dorsal ; une autre bande Elastoplast® est positionnée au niveau de la crête iliaque gauche pour maintenir le patient plaqué contre l'appui sacré.
- Afin de maintenir et de fixer la latéralité, on installe des appuis : sacré et dorsal. La jambe inférieure est fléchie à 90°.
- La jambe supérieure est tendue, elle repose sur la jambe inférieure, on interpose une plaque en gel viscoélastique entre les deux au niveau du genou. On place une talonnette en gel viscoélastique sous le talon.
- La table est positionnée en roulis, du côté opéré, entre 5 et 10°.

6.3 Vérifications ultimes

Une fois l'installation du patient en posture chirurgicale effectuée, une dernière vérification des points névralgiques où il existe des risques est réalisée :

- Le côté opéré : côté gauche
- La tête est bien en position anatomique, dans l'axe du corps sans extension du rachis cervical, il y a bien un rond de tête épais en viscosité avec une fente, les oreilles ne sont pas plicaturées et les yeux sont bien occlus.
- Il n'existe pas de compression au niveau des bras, pas d'extension du plexus brachial.
- L'épaule en contact de la table d'opération est bien dégagée.
- Il n'existe pas de compression axillaire, le bras inférieur n'est pas étiré. Il existe une protection entre le bras et l'appui si nécessaire.
- L'absence de contrainte (hyper extension, compression) sur le plexus brachial du bras supérieur est vérifiée. Il existe une protection entre le bras et l'appui si nécessaire.

- Le billot sous-scapulaire, s'il est positionné, doit être installé sous l'omoplate.
- Les jambes sont bien en position, jambe inférieure pliée à 80°, jambe supérieure tendue au-dessus de la jambe inférieure, une gélose entre les jambes au niveau des points de compression, une talonnette sous le talon de la jambe supérieure.
- Les appuis (sacré et dorsal) sont bien serrés.
- Des bas anti-thromboses sont portés par le patient s'il existe un risque thromboembolique.
- Le patient est réchauffé avec une couverture chauffante trouée, positionnée pour libérer la zone opératoire, à une température adaptée à sa température corporelle.
- Il n'y a pas d'appui sur les électrodes du scope.

6.4 Désinstallation en fin d'intervention

Il faut se préparer en fin d'intervention pour la désinstallation, car une fois le pansement fait, l'anesthésiste réveille rapidement le patient. Ainsi la procédure est la suivante :

- Prévoir suffisamment de personnel pour le retournement en décubitus dorsal.
- Un professionnel reste et sécurise le patient sur le côté.
- On enlève le billot sous-scapulaire si besoin.
- On retire le billot sous lombaire si besoin
- On retire les appuis sacrés et dorsal
- On enlève les géloses entre les jambes et la talonnette.
- Un anesthésiste doit être présent pour gérer et sécuriser le changement de position de la tête.
- On bascule le patient en décubitus dorsal, en sécurisant les bras ; et on positionne un appui-bras du côté opéré pour le repos du bras afin qu'il ne chute pas.
- On recouvre le patient avec sa couverture chauffante et un drap pour le confort du réveil.
- Une sangle de maintien est positionnée au niveau du muscle droit antérieur du patient pour sécuriser le patient lors de son réveil.

Risques

- Ventilatoire : il existe une hypoventilation par intubation sélective des deux bronches principales et exclusion du côté opéré (supérieur), une compression thoracique du côté non opéré (inférieur).
- Hémodynamique : en décubitus latéral droit, il y a une compression de la veine cave et donc une gêne au retour veineux.
- Les lésions oculaires peuvent être observées si la face est tournée vers la table et si les yeux ne sont pas occlus. Des abrasions des cornées peuvent se produire. Des ischémies rétinienne sont possibles en cas de compressions du globe oculaire associé à une hypotension artérielle prolongée.
- La compression du pavillon de l'oreille peut entraîner une nécrose si la tête repose sans rond de tête en gel viscoélastique sur la table et si l'intervention est prolongée.
- Le nerf sus-scapulaire peut être étiré lors de la rotation du malade. L'étirement entraîne des douleurs post-opératoires au niveau de l'épaule. Une compression du nerf grand-dorsal peut entraîner une gêne transitoire à la rétropulsion de l'omoplate.
- Il peut y avoir une compression axillaire avec un risque de plexus brachial (étirement du bras supérieur et compression du bras inférieur), ou de compression du nerf ulnaire, particulièrement quand le bras supérieur est posé sur un appui.
- Il existe un risque d'altération du débit sanguin cérébral par élongation du plexus cervical.
- Le poids du genou déclive reposant sur la table d'opération peut entraîner la compression du nerf péronier commun, ce qui a par conséquent d'empêcher la dorsiflexion du pied et la perte de sensibilité sur le dos du pied.

- Hypothermie.
- Lésions musculo-cutanées aux points d'appuis (tête, épaule inférieure, coudes, hanche inférieure, malléole externe inférieure et talons),
- Risques liés au changement de position :
 - Arrachage des tubulures, de la sonde d'intubation
 - Ostéo-articulaire : luxation, plexus...